

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

STAXI-2 · INVENTARIO DE EXPRESIÓN DE IRA ESTADO-RASGO 2

State-Trait Anger Expression Inventory-2 (Spielberger) – Medida psicométrica integral de componentes emocionales, expresivos y de control de la ira

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2)
Nombre en español	Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo 2
Sigla oficial	STAXI-2
Autores originales	Charles D. Spielberger (1999)
Adaptación hispanohablante	Juan José Miguel-Tobal, María Isabel Casado, Antonio Cano-Vindel y C. D. Spielberger (2001); Hogrefe TEA
Año de publicación original	1999 (versión y baremación estandarizada española en 2001)
Constructo primario	Experiencia de ira transitoria (Estado), predisposición a la ira (Rasgo), modos de expresión y control
Formato de administración	Autoinforme estructurado de 49 ítems distribuidos en 3 partes independientes con escalas Likert de 4 puntos
Población diana	Población adolescente y adulta (≥ 16 años) en ámbitos clínico, de la salud, forense y penitenciario
Tiempo de aplicación	10 a 15 minutos (49 ítems)
Régimen de acceso	Instrumento clínico comercial comercializado bajo licencia psicométrica (Hogrefe TEA Ediciones / PAR)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

El **Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo 2** (STAXI-2) representa la culminación del modelo multidimensional de Charles D. Spielberger sobre la hostilidad y las emociones negativas, integrando la distinción entre estado y rasgo con los mecanismos psicoconductuales de canalización y modulación de la cólera. La ira es un constructo clínico de máxima relevancia tanto en la salud mental (trastornos del control de impulsos, violencia interpersonal, psicopatía) como en la medicina psicosomática y conductual (hipertensión esencial, cardiopatía isquémica).

El instrumento organiza la experiencia de la ira en tres ejes esenciales: 1) **Estado de Ira**, como condición psicobiológica temporal con tensión muscular y activación simpática; 2) **Rasgo de Ira**, como disposición caracterológica a percibir situaciones como frustrantes y reaccionar con cólera; y 3) **Expresión y Control de la Ira**, que distingue con elegancia si el sujeto canaliza la hostilidad hacia el exterior mediante agresiones físicas o verbales (**Expresión Externa / Anger-Out**), si la reprime y almacena internamente de forma rencorosa (**Expresión Interna / Anger-In**), o si despliega estrategias activas de autocontrol conductual (**Control Externo**) y modulación cognitiva interna (**Control Interno**). Integra además el **Índice de Expresión de Ira (IEI)**, indicador global del desbalance entre expresión desadaptativa y regulación.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Escala / Subescala STAXI-2	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
Parte 1: Estado de Ira (E-IRA)	15 ítems	15 – 60	Mide intensidad actual. Desglosado en: Sentimiento (0-20), Expresión Física (0-20) y Expresión Verbal (0-20).
Parte 2: Rasgo de Ira (R-IRA)	10 ítems	10 – 40	Disposición habitual a airarse. Desglosado en: Temperamento de Ira (0-20) y Reacción de Ira ante frustraciones (0-20).
Parte 3: Expresión / Control • Expresión Externa (AX-O) • Expresión Interna (AX-I) • Control Externo (AC-O) • Control Interno (AC-I)	24 ítems (6 ítems c/u)	24 – 96 (6-24 c/u)	Canalización hacia terceros / insultos (AX-O); Represión / rumiación rencorosa interna (AX-I); Esfuerzo por calmar conductas agresivas (AC-O); Esfuerzo por relajarse y apaciguar el ánimo (AC-I).
Índice Expresión de Ira (IEI)	Fórmula global	0 – 72	IEI = (AX-O + AX-I) – (AC-O + AC-I) + 48. Medida de desregulación global de la ira.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna Estado (E-IRA)	Alpha de Cronbach = 0.88 – 0.93	Sobresaliente consistencia en la validación española de Miguel-Tobal et al. (2001).
Consistencia interna Rasgo (R-IRA)	Alpha de Cronbach = 0.82 – 0.86	Alta fiabilidad en población general, clínica y forense en España.
Consistencia interna Expresión/Control	Alpha = 0.74 – 0.88	AX-O (0.78), AX-I (0.74), AC-O (0.84), AC-I (0.86). Robusta coherencia factorial.
Fiabilidad test-retest Rasgo / Control	r = 0.75 – 0.82 (1 mes)	Estabilidad temporal adecuada para patrones estables de personalidad y regulación.
Validez convergente y divergente	r = 0.65 con BDHI; r = 0.58 con RV-Plutchik	Correlación positiva con escalas de hostilidad motora y heteroagresividad física.
Sensibilidad clínica en medicina	Asociación significativa con HTA	Los perfiles de Expresión Interna (AX-I) elevada correlacionan con reactividad cardiovascular e hipertensión arterial.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación ordinal Likert de 4 puntos:**
 - **Parte 1 (Estado de Ira, ítems 1 a 15):** 1 = Nada; 2 = Algo; 3 = Moderadamente; 4 = Mucho. (¿Cómo se siente ahora mismo?).
 - **Parte 2 (Rasgo de Ira, ítems 16 a 25):** 1 = Casi nunca; 2 = A veces; 3 = A menudo; 4 = Casi siempre. (¿Cómo se siente habitualmente?).
 - **Parte 3 (Expresión y Control, ítems 26 a 49):** 1 = Casi nunca; 2 = A veces; 3 = A menudo; 4 = Casi siempre. (¿Cómo reacciona cuando se enfada?).
- **Cómputo de Escalas:** Suma directa de los ítems de cada bloque temático.
- **Cálculo del Índice de Expresión de Ira (IEI):** $IEI = (AX-O + AX-I) - (AC-O + AC-I) + 48$
 - Rango del IEI: 0 a 72 puntos. Refleja el balance neto de hostilidad reprimida o proyectada frente al autocontrol.
- **Conversión a Baremos TEA:** Trasladar las puntuaciones directas a **Centiles (Pc)** y **Puntuaciones T** según el baremo normativo español por sexo.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Centil / Punt. T	Nivel de Ira	Significación Psicopatológica e Implicación Médica/Forense
Pc < 50 (T < 50)	Ira Baja / Óptimo Control	Nivel de ira dentro de límites adaptativos normales. Buenas habilidades de autorregulación emocional.
Pc 50 – 74 (T 50 – 59)	Ira Moderada / Habitual	Reacciones de enfado normales ante frustraciones cotidianas sin pérdida de control perjudicial.
Pc 75 – 89 (T 60 – 65)	Ira Elevada	Umbral clínico de advertencia. Tendencia a estallidos de cólera o rumiación rencorosa. Riesgo de conflicto interpersonal o somatización.
Pc ≥ 90 (T ≥ 66)	Ira Muy Elevada / Patológica	Gravedad psicopatológica severa. Si AX-O es alta: alto riesgo de violencia física o verbal. Si AX-I es alta: elevado riesgo cardiovascular/somático. Si IEI es alto: descontrol inhibitorio masivo.

PATRÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR VS. FORENSE (MIGUEL-TOBAL ET AL., 2001): 1) **Perfil Cardiovascular Peligroso:** Rasgo de Ira alto + Expresión Interna (AX-I) ≥ Pc 85 + Control Interno bajo (asociado a hipertensión y vasoespasmo coronario). 2) **Perfil Forense Violento:** Rasgo de Ira alto + Expresión Externa (AX-O) ≥ Pc 85 + Control Externo bajo (asociado a delitos y lesiones).

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Identificación del perfil dominante en el STAXI-2:

- Administrar el inventario en contextos de agresión física/verbal, accidentes de tráfico reiterados, delitos violentos o cardiopatía isquémica con patrón de conducta Tipo A.

Paso 2: Análisis por cuadrantes de expresión y control:

- **Cuadrante 1: AX-O Alta y AC-O Bajo (Ira Hacia Fuera Sin Freno):** Intervención focalizada en entrenamiento en desescalada de ira, pausas obligatorias (time-out), evitación de confrontación física y control de impulsos.
- **Cuadrante 2: AX-I Alta y AC-I Bajo (Ira Hacia Dentro / Hostilidad Reprimida):** Riesgo de somatización y depresión. Intervención en asertividad, comunicación honesta de disgustos y reestructuración cognitiva de agravios del pasado.
- **Cuadrante 3: IEI $\geq$ Centil 85 (Desregulación Global de la Ira):** Prioridad asistencial absoluta; balance de modulación roto.

Paso 3: Abordaje multimodal:

- TCC para el manejo de la ira (Novaco / Beck), técnicas de relajación progresiva muscular y biofeedback de coherencia cardíaca. Si coexiste agitación o trastorno límite, valorar pauta psicofarmacológica antiimpulsiva (estabilizadores como Topiramato o Ácido Valproico).

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 39 años, comercial de automoción, derivado a consulta de psicología por orden judicial tras verse implicado en una agresión física por una discusión de tráfico, con antecedentes de rotura de mobiliario en su empresa.

Resultados en el STAXI-2 (Baremos Varones Adultos):

- Estado de Ira (E-IRA): Centil 40 (calmado durante la evaluación en consulta).
- **Rasgo de Ira (R-IRA): Centil 92 (T = 68) -> Temperamento de ira explosivo.**
- **Expresión Externa de Ira (AX-O): Centil 95 (T = 72) -> Insultos, portazos y golpes a objetos.**
- Expresión Interna de Ira (AX-I): Centil 50 (no reprime la ira, la descarga inmediatamente).
- **Control Externo (AC-O): Centil 15 (T = 38) -> Muy deficiente capacidad de frenar la agresión.**
- Control Interno (AC-I): Centil 25 (T = 42) -> Escaso esfuerzo por apaciguar su mente.
- **Índice de Expresión de Ira (IEI): Centil 96 (T = 74) -> Desregulación crítica extrema.**

Plan Terapéutico y Seguimiento: El perfil tipificó de forma indudable un Trastorno Explosivo Intermitente. Se estructuró un plan de intervención cognitivo-conductual de 16 sesiones centrado en el modelo de Novaco: identificación precoz de signos fisiológicos de cólera (tensión mandibular, respiración agitada), empleo de autoinstrucciones de desescalada y técnica de “tiempo fuera” al volante. A los 6 meses de seguimiento, la subescala AX-O descendió a Centil 55 y el Control Externo (AC-O) ascendió a Centil 70, sin nuevos incidentes agresivos.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS MÉDICAS Y FORENSES:

- **Riesgo cardiovascular:** Sujetos con AX-I extrema tienen un riesgo triplicado de infarto agudo de miocardio en las 2 horas posteriores a un episodio de cólera intensa.
- **Violencia de género y doméstica:** Puntuaciones AX-O en Centil $\geq$ 90 exigen valorar la seguridad de familiares dependientes o pareja sentimental.
- **Consumo de tóxicos:** El alcohol y la cocaína desarticulan los mecanismos de Control Externo (AC-O), transformando el rasgo en agresión lesiva.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Ira vs. Agresividad instrumental:** El STAXI-2 evalúa la cólera emocional impulsiva y reactiva; en la psicopatía fría/predatoria la agresión se ejecuta sin activación de cólera.
- **Trastorno Bipolar (Manía/Hipomanía):** En fases maníacas la irritabilidad y el Estado de Ira se elevan masivamente, normalizándose en la eutimia.
- **Disfunción lóbulo frontal / TCE:** Secuelas neuropsicológicas por traumatismo craneoencefálico que comprometen la corteza orbitofrontal (desinhibición orgánica).

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Spielberger, C. D. (1999). **STAXI-2: State-Trait Anger Expression Inventory-2. Professional Manual.** Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
2. Miguel-Tobal, J. J., Casado, M. I., Cano-Vindel, A., & Spielberger, C. D. (2001). **STAXI-2: Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo: Manual.** Madrid: TEA Ediciones.
3. Forgays, D. G., Forgays, D. K., & Spielberger, C. D. (1997). Factor structure of the State-Trait Anger Expression Inventory. *Journal of Personality Assessment*, 69(3), 497–507. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6903_6
4. Cano-Vindel, A., Dongil-Collado, E., Salguero, J. M., & Wood, C. M. (2011). Intervención cognitivo-conductual en los desórdenes emocionales: Ansiedad, depresión y control de la ira. *Ansiedad y Estrés*, 17(2-3), 253–268.